Pneumonieprophylaxe



Pro Minute atmen wir durchschnittlich 12- bis 18-mal ein und wieder aus. Die Atmung ist die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge in unserem Körper. Deshalb sollten wir gut auf sie achten. Das gilt insbesondere für alte und pflegebedürftige Menschen. Denn sie erkranken nicht nur häufiger an einer Lungenentzündung (Pneumonie). Sie haben außerdem ein höheres Risiko, daran zu versterben.

pflege.de beschreibt in diesem Ratgeber die wichtigsten Maßnahmen einer Pneumonieprophylaxe.

Pneumonieprophylaxe: Definition

Die Pneumonieprophylaxe soll einer Lungenentzündung (Pneumonie) vorbeugen. Dazu werden verschiedene pflegerische Maßnahmen eingesetzt, die beispielsweise dafür sorgen, dass die Lunge gut belüftet wird oder Sekretstau und Infektionen vermieden werden.



INFO

Was ist eine Pneumonie?

Eine Pneumonie (Lungenentzündung) ist eine in den meisten Fällen von Bakterien verursachte Entzündung der Lungenbläschen und des umliegenden Gewebes. Die Folge: Flüssigkeit sammelt sich in der Lunge an, was den lebenswichtigen Sauerstoffaustausch erschwert. Mediziner unterscheiden zwischen einer ambulanten Pneumonie und der im Krankenhaus erworbenen nosokomialen Lungenentzündung.

Pneumonieprophylaxe: Für wen ist sie geeignet?

Jeder Mensch kann an einer Lungenentzündung erkranken. Doch besonders gefährdet sind **ältere** und **pflegebedürftige** Personen sowie Menschen mit einem **geschwächten Immunsystem**.[1]

Entsprechend ist eine Pneumonieprophylaxe für folgende Personengruppen besonders wichtig:

- Bettlägerige Menschen
- Menschen mit einer Herzerkrankung
- Personen mit eingeschränkter Motorik aufgrund von Demenz, Parkinson, Multipler Sklerose oder Ähnlichem
- Immungeschwächte Menschen, beispielsweise wegen einer Krebstherapie oder Mangelernährung
- Menschen mit einer Schluckstörung (Dysphagie)
- Patienten mit Schonatmung (etwa nach einer Operation, schmerzbedingt oder wegen eines schlechten Allgemeinzustands)
- Patienten mit Atemstörungen (zum Beispiel aufgrund von Asthma, Mukoviszidose oder COPD)
- Patienten mit einer Beeinträchtigung der oberen Atemwege, etwa nach einem Schlaganfall
- Beatmete Patienten

Warum ist Pneumonie für Senioren so gefährlich?

Ab dem 60. Lebensjahr steigt nicht nur das Risiko für eine Lungenentzündung, sie verläuft auch häufiger tödlich.

Ein **schwächeres Immunsystem**, **nachlassende Abwehrfunktionen der Atemwege** und eine sich **verändernde Lungenstruktur** macht ältere Menschen anfälliger für schwere Infektionen.

Hinzu kommen **chronische Vorerkrankungen**, **Schluckbeschwerden** und eine **erhöhte Anfälligkeit für Aspiration**, also die Gefahr, Essensreste oder Speichel einzuatmen. Das alles kann die Ausbreitung von Krankheitserregern begünstigen.

Ein weiteres Problem ist, dass die **Symptome oft nicht eindeutig** sind. Statt Fieber und Husten sind viele Senioren oder Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen gleichzeitig mit Pneumonie eher verwirrt und haben Durchfall, was zunächst eine andere Erkrankung vermuten lässt.

Pflegestandard zur Pneumonie-prophylaxe

Weil pflegebedürftige und ältere Menschen besonders gefährdet sind, an einer Lungenentzündung zu erkranken, zählt die Pneumonieprophylaxe zu den gängigen Prophylaxen in der Pflege.

Schließlich sind in Pflegeeinrichtungen Notrufe wegen Pneumonien der **zweithäufigste Grund für ärztliche Einsätze**.[1]

Werden die eine Lungenentzündung vorbeugenden Maßnahmen **konsequent durchgeführt**, kann das **Risiko einer Pneumonie deutlich sinken**.

INFO

Was sind Pflegestandards?

Pflegestandards sollen die Qualität der Pflege gewährleisten und verbessern. Fachgesellschaften entwickeln sie auf der Grundlage wissenschaftlicher wie pflegepraktischer Erkenntnisse. Pflegestandards dienen Pflegepersonal als Empfehlung, während die sogenannten Expertenstandards bundesweit verpflichtend sind.[2]

Pneumonieprophylaxe: Ziele

Das Hauptziel der Pneumonieprophylaxe ist es, eine **Lungenentzündung zu vermeiden**. Um das zu erreichen, müssen folgende Punkte in der Pflegeplanung berücksichtigt werden:[1]

- Für eine gute Belüftung der Lunge sorgen.
- Eine Ansteckung vermeiden.
- Sekret aus den Atemwegen mobilisieren und abtransportieren (Sekretmanagement).
- Eine Aspiration (Verschlucken) verhindern.

Pneumonieprophylaxe: Maßnahmen in der Pflege

Es gibt verschiedene Maßnahmen, die pflegebedürftige und ältere Menschen vor einer Lungenentzündung schützen können. Sie folgen dem sogenannten **LISA-plus-Prinzip**:[(1)]

L steht für „Lungenbelüftung„

I steht für „Infektion vermeiden“

S steht für „Sekretmanagement“

A steht für „Aspiration vermeiden“

Plus steht für ergänzende medizinische Maßnahmen

Lungenbelüftung

Eine starke Lunge schützt vor einem schweren Verlauf der Lungenentzündung. Deshalb ist ein wichtiger Bestandteil der Pneumonieprophylaxe die sogenannte Lungenbelüftung.

Um diese zu fördern, setzen Pflegeexperten auf drei Aspekte:

1. Mobilisation
2. Atemübungen
3. Spezielle Positionierungstechniken

Mobilisation

Regelmäßige Bewegung fördert die Lungenfunktion. Deshalb ist es wichtig, in seinen Alltag kleine **Bewegungseinheiten** wie etwa Treppensteigen oder Spaziergänge – möglichst an der frischen Luft – einzubauen.

Doch auch bettlägerige Patienten sollten so häufig wie möglich mobilisiert werden. Das können je nach Möglichkeiten zum Beispiel das **Sitzen auf der Bettkante** oder sogar das **Aufstehen** und **Gehen** sein.

Einfache Übungen wie das **Strecken der Arme nach oben oder zur Seite**, kombiniert **mit bewusstem Ein- und Ausatmen**, regen darüber hinaus die Atmung an.

EXPERTEN-TIPP

Integrieren Sie die Mobilisation in den Tagesplan. Zum Beispiel direkt vor der Morgenpflege oder vor dem Frühstück. Schon ein kurzes Aufsetzen im Bett oder kurze Gehversuche reduzieren das Pneumonierisiko deutlich.

Isabella Schüling
Pflegefachkraft, Pflegeberaterin & geprüfte Pflegesachverständige

Atemübungen

Spezielle Atemtechniken helfen, das Lungenvolumen zu trainieren und festsitzendes Sekret zu lösen. Das kann beispielsweise **das bewusste, tiefe Atmen in den Bauchraum** sein. Diese Übung bezieht das Zwerchfell mit ein und steigert so die Lungenaktivität.

Die **dosierte Lippenbremse** hilft dagegen, die Bronchien bei der Ausatmung zu stabilisieren und sie geweitet zu halten. Legen Sie dafür die Lippen entspannt aufeinander, atmen Sie durch die Nase ein und langsam durch die locker geschlossenen oder gespitzten, „gebremsten" Lippen wieder aus.[(3)]

Atemübungen **können auch Spaß machen**: Singen, Lachen oder das Pusten eines Wattebausches beziehungsweise Luftballons über einen Tisch führen dazu, dass der Mensch kräftig ausatmet und in der Folge auch tiefer einatmet.



TIPP

Holen Sie sich Unterstützung von einem Atemphysiotherapeuten

Risikopatienten sollten sich einer gezielten Atemschulung unterziehen. Spezialisierte Atemphysiotherapeuten unterweisen sie nicht nur in atemerleichternden Techniken. Auch das effektive Abhusten von Schleim können Betroffene dort lernen.

Positionierungstechniken

Für bettlägerige Patienten bieten sich spezielle Positionierungstechniken an, die die Atmung erleichtern und die Lungenbelüftung unterstützen.

Mehr über Techniken wie die Oberkörperhochlagerung, VATI-Lagerung, Drehdehnlagerung oder den Kutschersitz lesen Sie in unserem Ratgeber **Positionierung & Transfer in der häuslichen Pflege**.

Infektion vermeiden

Am besten ist es natürlich, wenn man sich gar nicht erst mit einem Pneumonie-Keim ansteckt. Infektionsprophylaxe ist hier das Stichwort. Konsequente Hygienemaßnahmen sind dabei besonders wichtig.

Außerdem schützt eine gründliche Mundpflege – mindestens zweimal täglich – vor Infektionen. Insbesondere Mundsoor kann unbehandelt eine Lungenentzündung auslösen.

Eine gewissenhafte Nasenpflege gewährleistet dagegen freie Nasenwege und erleichtert den Betroffenen das Atmen.

EXPERTEN-TIPP

Achten Sie bei der Infektionsprophylaxe auf eine einwandfreie Hygiene. Dazu zählt neben der Mundhygiene des Patienten auch die Hygiene der pflegenden Person. Das heißt, regelmäßiges Händewaschen mit anschließender Händedesinfektion und gegebenenfalls Mundschutz. Hygieneprodukte wie diese zählen zu den sogenannten Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch. Achten Sie außerdem auf saubere Inhalationsgeräte, falls Kochsalzlösung inhaliert wird.

Isabella Schüling
Pflegefachkraft, Pflegeberaterin & geprüfte Pflegesachverständige

Sekretmanagement

Für eine gute Belüftung der Lunge sollte die **Lunge frei von Sekret** sein. Doch besonders immobilen Menschen fällt es schwer, das Sekret auszuhusten. Deshalb sieht es die Pneumonieprophylaxe vor, das Sekret möglichst zu **verflüssigen**, damit es **leichter ausgehustet** werden kann.

Ausreichend Flüssigkeit – mindestens zwei Liter täglich, je nach individuell empfohlener Trinkmenge – und Inhalationen mit Kochsalzlösung können hier helfen. Ob Wasser, ungesüßter Tee oder Suppen – mit bunten Variationen können Sie die regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme abwechslungsreicher gestalten.

Manchmal müssen Pflegebedürftige dann aufgefordert werden, abzuhusten. Einige benötigen dabei Unterstützung.

EXPERTEN-TIPP

Mit einer Klopf- oder Vibrationsmassage unterstützen Sie das gezielte Abhusten und können die Durchlüftung der Lunge verbessern. Klopfen Sie dafür die Lungenabschnitte mit Fingerspitzen oder Handkante rhythmisch ab. Je nach Patientenzustand kann dies mehrere Minuten erfolgen.

Isabella Schüling
Pflegefachkraft, Pflegeberaterin & geprüfte Pflegesachverständige

Kann ein Patient gar nicht mehr eigenständig abhusten, muss das Sekret abgesaugt werden.

Aspiration vermeiden

Viele Lungenentzündungen im Alter sind auf Schluckstörungen zurückzuführen.(1)

Speisereste sowie Speichel – und mit ihnen dann **Krankheitserreger** – werden versehentlich eingeatmet und **gelangen in die Lunge**.

Eine Aspirationsprophylaxe, die Maßnahmen wie etwa das richtige Sitzen beim Essen und Trinken beinhaltet, kann dem entgegenwirken.

Ergänzende medizinische Maßnahmen

Einige Medikamente hemmen die Speichelproduktion, sedierende Präparate können dagegen das Schlucken beeinträchtigen.

Bei einer umfassenden Pneumonieprophylaxe gilt es, **Substanzen zu vermeiden, die sich negativ auf die Atmungs- und Schluckfunktion auswirken**.

Generell sollten Medikamente möglichst minimiert und gut aufeinander abgestimmt werden.

Zu den ergänzenden medizinischen Maßnahmen gehören neben einer Anpassung der Medikation auch regelmäßige Schutzimpfungen. Hier empfehlen Fachleute eine **Impfung gegen Grippe** sowie ab dem 60. Lebensjahr die **Pneumokokken-Impfung** sowie die **Covid-19-Impfung**.

BONUS

Ihr kostenloser Medikamentenplan

- ✔ Dokumentation leicht gemacht
- ✔ Unverzichtbar in der täglichen Pflege
- ✔ Übersichtlich und selbsterklärend

Jetzt herunterladen

Notfallmaßnahme bei akuter Pneumonie

Eine Lungenentzündung ist für alte und pflegebedürftige Menschen **eine ernst zu nehmende Lebensbedrohung**, vor allem wenn sie über längere Zeit unentdeckt bleibt.

Doch wird sie rechtzeitig erkannt, kann eine Pneumonie in den meisten Fällen **erfolgreich behandelt werden**.

Deshalb ist es wichtig bei den ersten Anzeichen einen **Arzt hinzuziehen**.

Schritt 1: Notruf wählen

Schwere akute Symptome wie **starke Atemnot**, **bläuliche Lippen, starker produktiver Husten, plötzliches hohes Fieber, Schüttelfrost** oder **Verwirrtheit** erfordern den **sofortigen Notruf unter der 112**.

Schritt 2: Person beruhigen

Bis der notärztliche Dienst eintrifft, sollten Sie die betroffene **Person erst einmal beruhigen**, da Panik die Atemnot zusätzlich verschlimmern kann.

Schritt 3: Kutschersitz

Außerdem sollten Sie ihr möglichst **in eine Haltung helfen, die die Atmung erleichtert**, zum Beispiel in den **Kutschersitz**:

Der Betroffene sitzt aufrecht auf einem Stuhl oder der Bettkante.

Die Füße sind vollständig auf dem Boden abgestellt.

Jetzt den Körper leicht nach vorn neigen.

Die Unterarme liegen auf den Oberschenkeln oder einer Tischplatte, die Hände hängen locker herab.

Schritt 4: Lippenbremse

Dann leiten Sie den Betroffenen zur **Lippenbremse** an:

1. Durch die Nase einatmen.

2. Durch die leicht geschlossenen oder gespitzten Lippen langsam und kontrolliert wieder ausatmen.

3. Es hilft, zusätzlich beim Ausatmen einen leichten „pf"-Laut zu erzeugen.

Lockern Sie außerdem zu eng sitzende Kleidung und sorgen Sie möglichst für frische Luft im Zimmer.



TIPP

Machen Sie einen Pflegekurs

Körperpflege, Hygienemaßnahmen und die richtige Positionierung von bettlägerigen Pflegebedürftigen – pflegende Angehörige können die Grundlagen der Pflege lernen. Pflegekassen und zahlreiche andere Anbieter bieten hierfür kostenlose Pflegekurse an.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Pneumonieprophylaxe?

Was sind die Ziele einer Pneumonieprophylaxe?

Welche Maßnahmen gehören zur Pneumonieprophylaxe?

Erstelldatum: 23.12.2025 | Zuletzt geändert: 12.08.2026

Quellenangaben

(1) S. Huhn (2021): Pneumonien enden oft tödlich. Heilberufe, Ausgabe 7-8/2021
www.springerpflege.de/pneumonieprophylaxe/pneumonien-enden-oft-toedlich/19317902 (letzter Abruf am 23.12.2025)

(2) Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (ohne Jahr): Expertenstandards und Auditinstrumente
www.dnqp.de/expertenstandards-und-auditinstrumente/ (letzter Abruf am 23.12.2025)

(3) Lungen Informationsdienst (2021): Atemtechniken und Atemschulung
www.lungeninformationsdienst.de/leben-mit-der-krankheit/atemschulung (letzter Abruf am 23.12.2025)

(4) Bildquelle
© iDoPixBox - Adobe Stock